Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção A da 26ª Vara Cível da Capital

AV DESEMBARGADOR GUERRA BARRETO, S/N, FORUM RODOLFO AURELIANO, ILHA JOANA BEZERRA, RECIFE - PE - CEP: 50080-800 - F:(81) 31810228

PROCESSO N° 0092881-90.2022.8.17.2001

AUTOR: ZILDA RAMOS DE ARAUJO MOURA

RÉ: BRADESCO SAÚDE S/A

SENTENÇA

Relatório ZILDA RAMOS DE ARAÚJO MOURA, qualificando-se pela pena de procurador constituído, aforou AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA PRODIVÓRIA DE URGÊNCIA em face de BRADESCO SAÚDE S/A, também qualificada, dizendo-se com fulcro na Constituição Federal e no Código de Defesa do Consumidor.

Reza a inicial que a Autora foi diagnosticada com "lúpus eritematoso sistêmico" e "plaquetopenia", razão porque, diante do insucesso de outras abordagens terapêuticas, sua médica assistente prescreveu tratamento com o uso do medicamento denominado "RITUXIMABE (MABTHERA)".

Aduz que, ao solicitar o fornecimento da droga, teve o pleito recusado pela Operadora Ré, ao argumento de que, tal como prescrito, estaria caracterizado o uso *off-label* do medicamento, esbarrando em restrição contratual.

Com isso, pugnou pela concessão de tutela provisória de urgência para o fim de compelir a Ré a fornecer a medicação aludida, pleiteando, no mérito, a condenação daquela no pagamento de indenização por dano moral.

Juntou documentos.

O pleito antecipatório foi indeferido na decisão de ID n° 113992197, que a Demandante logrou êxito em reverter mediante Agravo de Instrumento (ID de n° 117061942).

Citada, a Promovida apresentou contestação (ID de n° 125567678), em sede da qual sustentou que a terapêutica indicada constitui tratamento experimental e não se enquadra na hipótese de exceção prevista no art. 24, da Resolução Normativa n° 465/2021, da ANS, razão por que não está a Operadora obrigada a custeá-la, mormente por esbarrar o caso em cláusula de exclusão contratual.

No mais, discorreu sobre a taxatividade do rol da ANS, defendendo, alfim, inexistir dever indenizar danos morais.

Em sede de audiência, as partes restaram inconciliadas (ID de nº 126056951).

Decorreu o prazo para apresentação de Réplica, conforme certificou a Diretoria Cível (ID de nº 128206184).

Autos conclusos. É o que basta relatar.

Discussão Cuida-se de pretensão obrigacional e indenizatória, de conhecida possibilidade jurídica, aviada entre Partes com legitimidade *'ad causam'* e interesse de agir, porquanto aforada por beneficiária de seguro de saúde em face da respectiva Seguradora.

A controvérsia a ser dirimida reside em saber se o medicamento perseguido pela Autora deve ser fornecido pela Demandada, diante da afirmativa desta Parte de que o tratamento excede a cobertura contratual porque de caráter experimental.

Assiste razão à Promovida, senão vejamos.

De saída, registro que a Autora tem diagnóstico de "lúpus eritematoso sistêmico", logo não se pode dizer que o tratamento perseguido é antineoplásico – como sustentado na inicial - muito embora a droga prescrita à Paciente se destine ao combate de neoplasia.

Bem por isso, não pode a Demandante invocar as garantias previstas no art. 12, da Lei nº 9.656/1998, eis que ali está assegurada a cobertura para tratamentos antineoplásicos domiciliares e ambulatoriais, o que, como dito, não é o caso da Demandante.

Com efeito, o que pretende a Paciente é o uso *off-label* do medicamento antineoplásico, ou seja, a sua utilização para fins diversos daqueles previstos na respectiva bula e, pois, não aprovados pela ANVISA.

A Agência Nacional de Saúde, embora admita a exclusão assistencial do tratamento experimental como é o presente[1], prevê exceção à essa regra, todavia nem isso socorre a Demandante.

Isso porque, para que as Operadoras sejam obrigadas a garantir a cobertura de medicamentos para uso em hipótese distinta daquela aprovada pela ANVISA, deve antes haver aprovação da sua disponibilização no Sistema Único de Saúde - SUS, nos moldes definidos no inciso I, do parágrafo único, do art. 19-T, da Lei nº 8.080/1990, e também nos §§ 6º e 7º do art. 15 do Decreto nº 7.646/2011.

Não é o caso dos autos.

Ora, inexiste recomendação do uso do fármaco "RITUXIMABE (MABTHERA)" para o tratamento de "lúpus eritematoso sistêmico" emitida pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC).

Ao revés, no Relatório de Recomendação nº 761[2], de julho/2022, a referida Comissão consignou que *"após revisão da literatura, foi verificado que o rituximabe não possui evidência para sua incorporação no SUS e não possui autorização da Anvisa para uso em pacientes com LES".*

A prescrição, outrossim, nem mesmo está padronizada em protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde, conforme se infere da PORTARIA Nº 100/SAS/MS, de 07/02/2013[3].

Logo, o caso da Demandante não se enquadra nas hipóteses de exceção de cobertura para uso *off-label* de medicamentos, razão por que, mesmo após cognição exauriente, não vejo como modificar a conclusão já assentada desde o início do litígio, no sentido de que o pleito autoral excede a cobertura contratual.

Em consequência, ratifico o entendimento de que não há como impor à Promovida o custeio do tratamento, eis que, no cenário acima, caberia à Segurada a contratação de cobertura ampliada ou negociação de aditivo contratual para a cobertura do tratamento, o que não restou comprovado.

É bem verdade que a concessão de todos os medicamentos prescritos aos beneficiários de planos de saúde representaria a materialização de uma situação ideal, porém, tratando-se de uma relação jurídica que tem clara disciplina legal, tais normas devem ser respeitadas, mormente porque a prestação de serviço de saúde universal é obrigação do Estado[4].

Ignorar tal fato importaria em desprezar a regulação da atividade de assistência à saúde suplementar promovida pela ANS, que foi criada para esse fim, e obrigar as Operadoras a exercer o papel que incumbe ao Estado, o que não pode ser admitido.

Ressalto, por cautela, que este Juízo não é insensível à situação da Parte autora, tampouco ignora a proteção de seus direitos enquanto consumidora, todavia o Poder Judiciário deve atuar com prudência na apreciação de pleitos como o formulado nestes autos, atentando para o impacto econômico da decisão, sob pena de, a pretexto de garantir a proteção do consumidor, ocasionar desequilíbrio econômico-financeiro em detrimento das Operadoras, o que, em última análise, pode vulnerar os direitos de toda uma coletividade que usufrui da rede privada de assistência à saúde.

Por fim, quanto ao pleito indenizatório, deve, consequentemente, ser rejeitado, eis que, uma vez inexistindo dever legal de custeio do medicamento, não há o que se falar em ilícito praticado pela Ré.

Decisão ISTO POSTO, na esteira da fundamentação supra e do mais visto nos autos, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão embutida na atrial, DANDO resolução de mérito ao processo, o que faço com suporte no art. 487, inc. I, 2ª parte, do Código de Ritos Cíveis.

Em face da sucumbência, CONDENO a Demandante no recolhimento das custas processuais e no pagamento de verba honorária que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com arrimo no art. 85, § 2°, do CPC.

Ficará, todavia, sobrestada a exigibilidade do pagamento de tais verbas na hipótese de provimento do recurso interposto pela Autora (CPC, art. 98, § 3°).

Comunique-se à Sexta Câmara Cível o inteiro teor desta decisão.

Transitada em julgado, arquivem-se.

P.R.I.

Recife-PE, 21 de março de 2023.

Bel. DAMIÃO SEVERIANO DE SOUSA

Juiz de Direito

---

[1] RN nº 465/2021.

Art. 17. Parágrafo único. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais: I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental, isto é, aquele que: c) faz uso off-label de medicamentos, produtos para a saúde ou tecnologia em saúde, ressalvado o disposto no art. 24;

[2] https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/relatorios/2022/pcdt-lupus-eritematoso-sistemico (https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/relatorios/2022/pcdt-lupus-eritematoso-sistemico) (acesso em 21/03/2023)

[3] https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/protocolos/lupuseritematoso_sistemico-1.pdf (https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/protocolos/lupuseritematoso_sistemico-1.pdf) (acesso em 21/03/2023)

[4] Constituição Federal, art. 196. *A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.*

Assinado eletronicamente por: DAMIAO SEVERIANO DE SOUSA
21/03/2023 18:32:37
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 128518497

23032118323777500000125562032

IMPRIMIR GERAR PDF